



НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
(НСЗУ)

просп. Степана Бандери, 19, м. Київ, 04073, тел.: (044) 426-67-77, (044) 290-06-91

E-mail: info@nszu.gov.ua, сайт: www.nszu.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 42032422

від _____ 20__ р. № _____

На № _____ від _____ 20__ р.

Власникам комунальних або
державних закладів охорони здоров'я
(за списком)

Обласним військовим адміністраціям
(до відома)
Міністерство охорони здоров'я
України
(до відома)

Національна служба здоров'я України (НСЗУ), як центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, керуючись у своїй діяльності Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, відповідно до покладених на неї Положенням про Національну службу здоров'я України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1101 (далі - Положення), завдань, з метою належного виконання вимог Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (далі - Закон), зокрема забезпечення цільового та ефективного використання коштів за програмою медичних гарантій, інформує.

Згідно з пунктом 5 договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (далі — Договір), укладеного між НСЗУ та відповідним надавачем медичних послуг, моніторинг – комплекс заходів, які здійснюються замовником, щодо збору та аналізу інформації стосовно виконання надавачем умов договору.

Пунктом 5¹ Договору визначено, що автоматичний моніторинг – комплекс постійних автоматизованих заходів, заснованих на ризик-орієнтованому підході, які здійснюються з використанням інформаційно-комунікаційних систем, зокрема інформаційної системи замовника, для отримання інформації, необхідної для вирішення питання про проведення фактичного моніторингу, планування фактичного моніторингу, верифікації даних, що містяться в електронній системі охорони здоров'я, та застосування заходів, передбачених цим договором.

Відповідно до підпунктів 2, 3 та 13 пункту 19 Договору, надавач медичних послуг зобов'язується:



відповідати вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, у тому числі щодо доступності медичних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до законодавства, умовам закупівлі;

дотримуватися вимог законодавства, зокрема порядків надання медичної допомоги, табелів матеріально-технічного оснащення, в тому числі примірних, галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я, а також забезпечувати дотримання підрядниками зазначених вимог;

своєчасно вносити до системи повну та достовірну інформацію, в тому числі медичну документацію та звіти про медичні послуги, медичні записи, записи про направлення і рецепти у порядку, встановленому законодавством, з урахуванням положень специфікації.

Підпунктами 1 та 3 пункту 6 Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров'я, що діє в організаційно-правовій формі державного або комунального некомерційного підприємства, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 792 «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров'я та типових форм контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров'я», передбачено, що керівник підприємства зобов'язаний:

організувати належне виконання завдань, передбачених статутом підприємства, та укладених договорів про медичне обслуговування населення;

організувати надання підприємством належного, доступного, кваліфікованого медичного обслуговування населення.

Абзацами першим, другим та восьмим пункту 7 Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 792 «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров'я та типових форм контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров'я» (далі - Порядок), встановлено, що контракт з керівником державного, комунального закладу охорони здоров'я може бути розірваний на підставах, передбачених цим Порядком, умовами контракту та законодавством. **Підставою розірвання контракту у разі надходження до органу управління звернення МОЗ або обласної, Київської міської державної адміністрації (військової адміністрації) може бути наявність порушень, виявлених в процесі проведення моніторингу виконання умов договорів про медичне обслуговування населення та про реімбурсацію за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.**

НСЗУ у 2025 році відповідно до покладених на неї завдань, з метою забезпечення цільового та ефективного використання коштів за програмою

медичних гарантій, було проведено планові та позапланові моніторинги виконання надавачами медичних послуг умов Договорів.

За результатами досліджень виявлено численні та систематичні випадки порушень з боку надавачів медичних послуг умов Договорів, за які було застосовано відповідні заходи реагування, зокрема й перерахунок сплачених коштів за Договорами за відповідними пакетами медичних послуг (перелік надавачів медичних послуг та суми перерахунків додаються).

В доповнення до вже діючих алгоритмів автоматичного моніторингу, НСЗУ було впроваджено нові алгоритми автоматичного моніторингу, здійснено автоматичний моніторинг, зокрема за пакетами медичних послуг «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах», «Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня», «Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим і дітям» та «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям» шляхом проведення аналізу електронних медичних записів (далі - ЕМЗ), внесених до електронної системи охорони здоров'я (далі - ЕСОЗ) надавачами медичних послуг, та виявлено факти внесення ЕМЗ, що містять недостовірну та/або неповну інформацію про діагнози та/або проведені пацієнтам інтервенції, та/або необґрунтоване лікування пацієнта.

За результатами автоматичного моніторингу ЕМЗ за новими алгоритмами автоматичного моніторингу виявлено численні та систематичні випадки зловживань щодо внесення до ЕМЗ ймовірно недостовірних діагнозів та інтервенцій з метою віднесення таких медзаписів до діагностично-споріднених груп (далі - ДСГ) з більш високими ваговими коефіцієнтами (перелік надавачів медичних послуг та суми перерахунку додаються) за такими напрямками:

1. за ДСГ J08 Інші пересадки шкіри і видалення некротичних тканин, J09 Процедури при пілонідальній кістці та в періанальній ділянці, J10 Загальні пластичні операції на шкірі, підшкірній клітковині і молочних залозах за медичними показаннями, J11 Інші операції на шкірі, підшкірній клітковині і молочних залозах.

За результатами проведеного автоматичного моніторингу та виявлення невідповідності критеріям повноти та достовірності ЕМЗ, віднесених до пакетів медичних послуг «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» та «Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня», за послугами, віднесеними до ДСГ J08-J11, усім без виключення надавачам медичних послуг здійснено коригування запланованої вартості медичних послуг з 01.08.2025 за зазначеними напрямками (в частині глобальної ставки на місяць).

Крім того, проведено перерахунок фактичної вартості наданих медичних послуг за вказаними напрямками в частині оплати за проліковані випадки, шляхом включення до звітів про обсяг наданих медичних послуг розрахунку – коригування за минулі звітні періоди 2025 року.

2. За ДСГ N08 Ендоскопічні і лапароскопічні операції на органах жіночої репродуктивної системи, N09 Інші операції на піхві, шийці матки і жіночих зовнішніх статевих органах, N11 Інші загальні втручання щодо

жіночої репродуктивної системи, N12 Операції на матці і придатках матки при злоякісних новоутвореннях.

При проведенні автоматичного моніторингу за пакетом медичних послуг «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» в частині наданих послуг за ДСГ N08-N12 виявлено ЕМЗ з проведеними інтервенціями без відповідного для цих інтервенцій додаткового або основного діагнозу, з відсутністю додаткових діагнозів, з відсутністю проведення обов'язкових досліджень відповідно до галузевих стандартів (КТ, МРТ, біопсія) для діагнозів новоутворень, з відсутністю інтервенції зі знеболення при оперативних втручаннях, лікування у відділенні інтенсивної терапії при діагнозах, коли таке лікування не показано або при малій тривалості лікування.

В цілому сума перерахунку фактичної вартості наданих медичних послуг, віднесених до ДСГ N08-N12, за пакетами медичних послуг «Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня» і «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» в частині оплати за проліковані випадки відповідно до погоджених Експертною радою алгоритмів становить 310,9 млн грн.

3. За ДСГ I02 Мікрovasкулярні пересадки тканин чи шкіри, крім рук.

При проведенні автоматичного моніторингу за пакетом медичних послуг «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» в частині наданих послуг за ДСГ I02 Мікрovasкулярні пересадки тканин чи шкіри, крім рук, виявлено ЕМЗ про проліковані випадки, у яких до ЕСОЗ внесено інформацію про коротку тривалість госпіталізації, яка не відповідає складності випадків, і проведені процедури та/або втручання без відповідного для цих інтервенцій основного або додаткового діагнозу, до яких мають відноситись складні випадки хірургічних операцій з пересадки тканин чи шкіри, що потребують тривалого лікування.

Такі ЕМЗ за ДСГ I02, у яких виявлені зазначені вище невідповідності, за результатом автоматичного моніторингу були визнані такими, що потребують перегляду з наступним віднесенням до відповідної ДСГ та пакету медичних послуг або такими, що не відповідають критеріям повноти і достовірності та не підлягатимуть оплаті.

4. За іншими ДСГ.

При проведенні автоматичного моніторингу за пакетами медичних послуг «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» та «Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня» в частині наданих послуг за ДСГ:

B02 Операції на черепі

B03 Операції на хребті

D02 Операції на голові та шиї

D12 Інші операції на вусі, носі, роті і горлі

- E01 Складні операції на грудній клітці
- G02 Складні операції на тонкому і товстому кишечнику
- G03 Операції на шлунку, стравоході і дванадцятипалій кишці
- G11 Операції на задньому проході та стомі
- H01 Шунтування та операції на підшлунковій залозі, печінці
- H02 Складні операції на біліарному тракті
- H05 Діагностичні процедури на гепатобіліарній системі
- H06 Інші загальні втручання на гепатобіліарній системі і підшлунковій залозі
- H07 Відкрита холецистектомія
- H08 Лапароскопічна холецистектомія
- I10 Інші операції на ший та спині
- I12 Різні операції на опорно-руховому апараті через інфекції/запалення кісток/суглобів

було виявлено ЕМЗ про проліковані випадки, у яких до ЕСОЗ внесено інформацію про проведені процедури та/або втручання без відповідного для цих інтервенцій основного або додаткового діагнозу.

Такі ЕМЗ за наведеними ДСГ, у яких основний та/або додатковий діагноз не відповідає інтервенціям про проведення процедур і втручань, за результатом автоматичного моніторингу були визнані такими, що потребують перегляду з наступним віднесенням до відповідної ДСГ та пакету медичних послуг або такими, що не відповідають критеріям повноти і достовірності та не підлягатимуть оплаті.

Також автоматичний моніторинг проведено за такими ДСГ:

- 1) H01 «Шунтування та операції на підшлунковій залозі, печінці», H02 «Складні операції на біліарному тракті», H05 «Діагностичні процедури на гепатобіліарній системі», H06 «Інші загальні втручання на гепатобіліарній системі і підшлунковій залозі».
- 2) I10 «Інші операції на ший та спині»; I12 «Різні операції на опорно-руховому апараті через інфекції/запалення кісток/суглобів».
- 3) B02 «Операції на черепі», B03 «Операції на хребті».
- 4) D02 «Операції на голові та ший», D12 «Інші операції на вусі, носі, роті і горлі».
- 5) E01 «Складні операції на грудній клітці».
- 6) G02 «Складні операції на тонкому і товстому кишечнику».

5. Стаціонарні випадки, у яких надавачами медичних послуг внесено інформацію про застосування до пацієнта інтервенцій ШВЛ.

НСЗУ провела автоматичний моніторинг за пакетами медичних послуг «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах», «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій», «Готовність та забезпечення надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на

території, де ведуться бойові дії» (в частині послуг 57.3 «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» та 57.4 «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій») з метою перевірки повноти і достовірності інформації, внесеної до ЕСОЗ щодо стаціонарних випадків, у яких надавачами медичних послуг внесено інформацію про застосування до пацієнта інтервенцій:

- 13882-00 Безперервна допоміжна ШВЛ ≤ 24 год;
- 13882-01 Безперервна допоміжна ШВЛ > 24 ;
- 13882-02 Безперервна допоміжна ШВЛ ≥ 96 год;
- 13882-03 Безперервна допоміжна ШВЛ ≥ 336 год;
- 92209-00 Неінвазивна ШВЛ ≤ 24 год;
- 92209-01 Неінвазивна ШВЛ > 24 і < 96 год;
- 92209-02 Неінвазивна ШВЛ ≥ 96 год;
- 92211-00 Комбінована допоміжна ШВЛ ≥ 96 год.

За результатом автоматичного моніторингу внесених до ЕСОЗ ЕМЗ про надані медичні послуги у стаціонарних умовах, з урахуванням зазначеного, у таких ЕМЗ результату лікування виявлено випадки, у яких термін госпіталізації пацієнта менше ніж термін, зазначений у інтервенціях про застосування ШВЛ, або у яких термін госпіталізації пацієнта не відповідає терміну зазначеному у інтервенції про застосування ШВЛ з урахуванням додаткового періоду стабілізації, який потрібен пацієнту для відновлення після застосування ШВЛ.

Такі ЕМЗ за пакетами медичних послуг «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» та/або «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій», та/або «Готовність та забезпечення надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на території, де ведуться бойові дії», у яких термін госпіталізації не відповідає терміну, зазначеному у інтервенціях про проведення процедур і втручань 13882-00, 13882-01, 13882-02, 13882-03, 92209-00, 92209-01, 92209-02, 92211-00 за результатом автоматичного моніторингу були визнані такими, що не відповідають критеріям повноти і достовірності і не підлягають оплаті.

Також за результатами автоматичного моніторингу внесених до ЕСОЗ ЕМЗ про надані медичні послуги, які були віднесені до ДСГ F40, та включені до звітів про надані медичні послуги, були виявлені випадки, у яких тривалість надання послуги (госпіталізації) не відповідає внесеній у цьому ЕМЗ інформації про проведені процедури та/або втручання, зокрема за інтервенцією 13882-01 «Ведення пацієнта при проведенні безперервної допоміжної ШВЛ, > 24 і < 96 годин».

Такі ЕМЗ за ДСГ F40, у яких термін госпіталізації не відповідає терміну, зазначеному у інтервенціях про проведення процедур і втручань, за результатом автоматичного моніторингу були визнані такими, що не відповідають критеріям повноти і достовірності і не підлягатимуть оплаті.

6. За пакетами «Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим і дітям» та «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям».

НСЗУ провела автоматичний моніторинг за пакетами «Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим і дітям» та «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям» в частині перевірки наявності в ЕМЗ пацієнтів, послуги яким віднесені до цих пакетів, щонайменше 5 клінічних ознак віднесення дорослого пацієнта до паліативного.

Перелічені вище випадки є лише окремими напрямками автоматичного моніторингу.

Поряд з цим, крім впровадження нових алгоритмів автоматичного моніторингу, НСЗУ на постійній основі здійснюється робота, яка також направлена на виявлення фактів внесення недостовірних ЕМЗ до ЕСОЗ, а саме:

проводиться співставлення інформації, отриманої з ДРАЦСГ, та інформації з Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів, з метою виявлення фактів внесення ЕМЗ пацієнтів, які ідентифіковані як померлі особи;

здійснюється перевірка зареєстрованого медичного персоналу та обладнання надавачів медичних послуг відповідно до умов закупівлі за відповідними пакетами медичних послуг;

проводиться перевірка відповідності надавача медичних послуг вимогам до спеціалізації та кількості фахівців умов закупівлі медичних послуг, які надаються за Договорами, встановлюється факт наявності у надавача медичних послуг мінімальної кількості необхідного медичного персоналу.

Звертаємо увагу, що підпунктом 14 пункту 4 Положення передбачено, що НСЗУ відповідно до покладених на неї завдань інформує уповноважені державні органи та органи місцевого самоврядування про виявлені порушення умов договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій і договорів про реімбурсацію та звертається до суду у випадках, передбачених законом.

Згідно абзацу другого пункту 2 Порядку уповноваженим виконавчим органом управління власника закладу охорони здоров'я є центральний орган виконавчої влади, інший державний орган або виконавчий орган місцевого самоврядування, уповноважений власником на здійснення управління державним або комунальним закладом охорони здоров'я.

З огляду на зазначене вище, інформуємо про встановлення численних та систематичних випадків зловживань з боку надавачів медичних послуг, а також внесення працівниками надавачів медичних послуг до ЕСОЗ недостовірної та/або неповної інформації, що призвело до надмірної виплати бюджетних коштів, для розгляду та вжиття відповідних заходів реагування в межах компетенції.

У додатку до листа надається інформація про направлені повідомлення про виявлені порушення, суми перерахунку за результатами автоматичного

моніторингу за 2025 рік в розрізі підпорядкованих надавачів медичних послуг (у разі здійснення) окремими аркушами.

Звертаємо увагу власників закладів охорони здоров'я, обласні військові адміністрації та Міністерство охорони здоров'я України, що інформування про виявлені порушення та здійснені перерахунки буде поступово здійснено всім власникам закладів охорони здоров'я.

Про результати розгляду листа просимо повідомити НСЗУ у встановленому законодавством порядку.

Заздалегідь вдячні за співпрацю!

Додаток: інформація про направлені повідомлення про виявлені порушення, суми перерахунки за результатами автоматичного моніторингу в розрізі підпорядкованих надавачів медичних послуг у форматі Excel.

Голова

Наталія ГУСАК